
QCM • CONCOURS

Concours de recrutement des IDE 2ème Grade

Technicien de Radiologie

Specialite : Technicien de Radiologie

Annee : 2013

54 questions

Questions

1 Les critères de réussite correspondant à l'incidence de profil du rachis dorsal :

A	Dégagement des trous de conjugaison
B	Absence de dédoublement du mûr postérieur
C	L'aspect linéaire des plateaux vertébraux
D	Les espaces intervertébraux bien visibles
E	Position médiane de la ligne des épineuses

2 La position du patient dans l'incidence du rachis dorsal en oblique antéropostérieure est :

A	Malade debout, le côté à radiographier s'écarte du plan d'appui en faisant un angle de 70° du plan d'examen
B	Malade debout, le côté à radiographier s'écarte du plan d'appui en faisant un angle de 30° du plan d'examen
C	Malade debout, le côté opposé à celui à radiographier s'écarte du plan d'appui en faisant un angle de 70° du plan d'examen
D	Malade debout, le côté opposé à celui à radiographier s'écarte du plan d'appui en faisant un angle de 30° du plan d'examen

3 Le rayon directeur horizontal centré à la hauteur de la fourchette sternale est le centrage de l'incidence

A	charnière cervico-dorsale
B	RD de face
C	partie supérieure des côtes de face
D	Sternum de face
E	sternum de profil

4 l'incidence radiologique qui permet d'étudier les interlignes intervertébrales du rachis lombaire

- | | |
|---|--|
| A | l'incidence de face debout en antéropostérieur |
| B | l'incidence de face debout en antéropostérieur |
| C | l'incidence de Desèze |
| D | l'incidence de face en décubitus dorsal |
| E | l'incidence de face en pro cubitus |

! Options A and B are identical in the source.

5 R.D de l'incidence du Coccyx de face en postéro/antérieure

- | | |
|---|-------------------|
| A | descendant de 10° |
| B | ascendant de 10° |
| C | descendant de 15° |
| D | descendant de 20° |
| E | ascendant de 20° |

6 L'incidence radiologique en obliques des côtes permet de :

- | | |
|---|---|
| A | Préciser la lésion osseuse |
| B | Projeter les côtes sur l'abdomen |
| C | Préciser l'extension de la lésion vers la plèvre |
| D | Préciser l'extension de la lésion vers les parties molles |
| E | Projeter de face la portion moyenne de la côte |

7 La présence d'images hydroaériques sur un ASP debout avec RDH est secondaire à :

- A Lithiases rénales
- B Une cholécystite aiguë
- C Une occlusion mécanique
- D Iléus biliaire
- E Un trouble de résorption (diarrhée)

8 Au cours d'un UIV l'absence d'élimination d'excrétion peut être due à :

- A Un syndrome obstructif
- B Malade non préparé
- C Une insuffisance rénale
- D Patient non à jeun
- E Syndrome de jonction poly urétral

9 Les critères de réussite d'un cliché standard pulmonaire de face en haute tension sont :

- A La symétrie des omoplates
- B Dégagement des parenchymes pulmonaires
- C Bonne visualisation du thorax osseux
- D Effacement de la moitié inférieure du rachis dorsal
- E La symétrie des deux clavicules

10 Pour l'étude de l'apophyse coronoïde, le coude doit être :

- A De face, main en supination
- B De profil strict
- C En oblique
- D De face, main en pronation

! Only 4 options available in source.

11 La cavité glénoïde est visible de face en :

- A Incidence de Neer
- B Incidence de Bloom obata
- C Incidence de Lamy
- D Incidence de Dédie

! Only 4 options available in source.

12 Un poignet traumatisé nécessite :

- A profil cubital
- B Schreek I
- C Face avec légère déviation cubital
- D Face avec inclinaison du R.D de 30°

! Only 4 options available in source.

13 La tête humérale est vue de face avec :

- A Main en pronation forcée
- B Main en supination
- C Main en supination forcée
- D Main de profil

! Only 4 options available in source.

14 Parmi ces propositions, lesquels sont les critères de réussite du coude de profil :

- A Superposition l'axe épicondyle-épitrochl■
- B Sommet de l'olécrâne au milieu de la fossette coronoïdienne
- C La cupule radiale empiète de moitié l'apophyse coronoïde
- D Bon dégagement de l'interligne cubito-humérale

! Only 4 options available in source.

15 Que fait-on si un organe critique se trouve dans le champ d'irradiation :

- A Utiliser les bolus
- B Choisir la technique d'irradiation DSA
- C Ne pas irradier la tumeur
- D Utiliser les caches
- E Utiliser les moyens de contention

16 La dosimétrie permet de déterminer :

A	La dose totale d'irradiation
B	Le temps de traitement
C	Le volume cible
D	Les moyens de contention
E	Répartition de la dose dans le volume tumoral

17 La détermination du volume cible est en fonction :

A	Bilan radiographique
B	Bilan biologique
C	Du compte-rendu opératoire et histologique
D	L'histoire naturelle du cancer

! Only 4 options available in source.

18 On a réalisé une incidence de face du bassin à un patient reçu à la radiologie des urgences, le cliché a montré une fracture pour compléter par une incidence de l'articulation sacro iliaque du côté droit (patient non mobilisable) quelle est l'incidence de choix à réaliser :

A	Décubitus dorsal avec inclinaison de RD de 25° à 30° vers la tête
B	Décubitus dorsal avec inclinaison du RD de 25° à 30° de dehors en dedans
C	Pro cubitus avec inclinaison du RD de 40° à 50° de dedans en dehors
D	Pro cubitus avec inclinaison du RD de 25° à 30° de dehors en dedans
E	Décubitus dorsal avec inclinaison du RD de 25° à 30° de dedans en dehors

19 Quelle est la ou les incidences du profil de la hanche qui permet d'utiliser le Potter (ou Portique):

A	Arcelin
B	Clark
C	Urétrale
D	Lequesne
E	Salpetrière

20 Pour l'incidence 3/4 obturateur :

A	On soulève le coté à radiographier de 40° à 45°
B	Le RD est centré au milieu de sommets des crêtes iliaques
C	Permet de projeter l'aile iliaque de face
D	Permet de voir le trou obturateur ouvert
E	Permet de voir le cotyle de profil

21 L'incidence urétrale de la hanche :

A	on soulève le côté opposé à celui à RX de 45°
B	Le membre à RX est en rectitude
C	sa réalisation ne permet pas l'utilisation d' Potter
D	on soulève le coté à RX de 45°
E	sur l'image, on voit le grand trochanter dégagé du col

22 Pour un patient présentant une fracture du col fémoral quel est le ou les groupes d'incidences

- | | |
|----------|---|
| A | Face de la hanche sans rotation interne et l'incidence urétrale |
| B | Face de la hanche avec rotation interne et l'incidence urétrale |
| C | Face de la hanche sans rotation interne et Arcelin |
| D | Face de la hanche avec rotation interne et Arcelin |

! Only 4 options available in source.

23 Un patient ne pouvant pas faire l'extension complète de la jambe sur la cuisse se présente pour radiographie face et profil du genou droit. Quelles sont les incidences de choix à réaliser :

- | | |
|----------|--|
| A | Face en antéro postérieure en décubitus dorsale |
| B | Face en postéro-antérieur tient en pro cubitus |
| C | Profil avec RDH patient en décubitus dorsale |
| D | Profil avec RDV patient en décubitus latérale sur le coté gauche |
| E | Profil avec RDV patient en décubitus latérale sur le coté droit |

24 Pour bien dégager l'articulation peronéo-tibiale supérieur:

- | | |
|----------|---|
| A | On incline le RD de 20° de dehors en dedans et 5 à 10° de haut en bas |
| B | On incline le RD de 45° de dehors en dedans et 5 à 10° de haut en bas |
| C | On incline le RD de 45° de bas en haut |
| D | On fait une rotation externe de 20° |
| E | On fait une rotation interne de 45° |

25 Un patient admis en urgence présentant une fracture ouverte de la jambe. Quelle sont les incidences nécessaires à réaliser:

A	Jambe de face avec rotation interne
B	Jambe de face sans rotation interne
C	Poumon face debout en antero postérieur
D	Jambe de profil avec RDH et patient en décubitus dorsale
E	Jambe de profil avec RDV et patient en décubitus latérale

26 L'incidence verticale du calcanéum, retro-tibiale descendante :

A	Peut être réalisée debout ou décubitus dorsale
B	Peut être réalisée debout seulement
C	Peut être réalisée de manière symétrique
D	Permet d'explorer la partie postérieure du calcanéum
E	Permet d'explorer la partie moyenne du calcanéum

27 L'incidence Bifocale du pied dite de « DEZESE »:

A	Permet de calculer l'angle de Bohler
B	Nécessite deux expositions
C	Nécessite l'utilisation de deux films
D	C'est incidence fondamentale
E	Permet d'explorer la totalité du pied

28 Un technicien de radiologie se plaçant (1m) d'une source de rayonnement reçoit $324\mu\text{Gy}$ à quelle distance doit-il se placer pour ne recevoir que $4\mu\text{Gy}$:

A	10.5m
B	10.0m
C	9.5m
D	9.0m
E	9.25m

29 En radioprotection les effets déterministes :

A	Sont des effets aléatoires
B	Apparaissent à partir d'un certains seuil d'irradiation
C	Les organes atteint peuvent être la moelle osseuse le cristallin ou l'œil
D	Ne concernent pas l'irradiation globale
E	Sont des effets à long terme

30 Les trois principes fondamentaux de radioprotection sont:

A	La justification, limitation de doses et la distance
B	La justification, l'optimisation et les écrans
C	Limitation de doses, la justification et l'optimisation
D	Limitation de doses, optimisation et le temps
E	L'optimisation, le temps et la distance

31 La dose absorbée:

A	C'est le nombre de transition nucléaire par seconde
B	Son unité est le Gray
C	C'est l'énergie absorbée par unité de masse de matière irradiée
D	C'est le facteur de pondération tissulaire
E	Sa formule est : $E = \sum T \cdot W_T \cdot HT$

32 L'incidence face du crâne:

A	Permet de projeter les rochers dans les fenêtres radiologiques formées par les orbites
B	OM=-25° et S=0°
C	OM=+25° et S=0°
D	Parmi les critères de réussites : distance ligne innominée-table interne de la voûte latérale identiques des deux cotés
E	Les rochers sont dégagés dans leur totalité du massif facial

33 L'incidence axiale (Hirtz):

A	Est l'incidence de choix pour dégager la voûte du crâne
B	OM=-120° et S=0
C	Centrage au milieu de la ligne bi-auriculaire
D	Contre indiquée en cas d'insuffisance vertébro-basilaire
E	Comme critère de réussite : l'arc mandibulaire se projette en avant des sinus frontaux

34 « La lame quadrilatère de la selle turcique se projette dans la moitié postérieure du trou occipital » ce critère de réussite correspond à quelle incidence :

A	Blondeau
B	Face haute
C	Hirtz latéralisée
D	Semi- axiale
E	Profil du crâne

35 Selon les normes de l'ICRU, le volume cible anatomo-clinique (CTV) tient compte des mouvements du malade, des imperfections des faisceaux :

A	Vrai
B	Faux
C	N/A
D	N/A

! True/False question filled with dummy options.

36 La radiothérapie palliative se fait de façon accélérée en délivrant des doses élevées par fraction :

A	Vrai
B	Faux
C	N/A
D	N/A

! True/False question filled with dummy options.

37 Les RX et les Rayons Gamma sont utilisés en médecine nucléaire a visée diagnostique et thérapeutique :

A	Vrai
B	Faux
C	N/A
D	N/A

! True/False question filled with dummy options.

38 La médecine nucléaire est une technique d'imagerie fonctionnelle et morphologique qui permet d'explorer la totalité des organes

A	Vrai
B	Faux
C	N/A
D	N/A

! True/False question filled with dummy options.

39 Quelles sont les incidences radiologiques à réaliser

A	Incidence Blondeau
B	Incidence de profil du crâne
C	Incidence de Gosserez
D	Incidence de profil des os propres du nez
E	Incidence de face haute

40 Quelle est votre conduite par rapport à la réaction de l'enfant

- | | |
|---|--|
| A | Autoriser la maman à rester avec lui dans la salle seulement |
| B | Demander à la maman si elle est enceinte avant de l'autoriser à rester avec lui |
| C | Porter à la maman une blouse plombée si elle restera avec son fils dans la salle |
| D | Ne pas faire l'examen radiologique à l'enfant |
| E | Obliger l'enfant à faire l'examen radiologique sans la présence de sa maman |

41 Parmi les disciplines suivantes, quelles sont celles qui n'existent pas dans un Hôpital Local ?:

- | | |
|---|-------------|
| A | Médecine |
| B | Obstétrique |
| C | Psychiatrie |
| D | Chirurgie |
| E | Pédiatrie |

42 Quelle est parmi les structures suivantes celle qui représente la 1ère source de financement du Système National de Santé ?

- | | |
|---|-------------------------------|
| A | Les collectivités locales |
| B | Les ménages |
| C | Les entreprises publiques |
| D | La coopération internationale |
| E | L'Etat |

43 Une maladie épidémique qui ne connaît pas de frontière est appelée :

- A Epidémie
- B Endémie
- C Pandémie
- D Cas sporadique

! Only 4 options available in source.

44 La prise en charge des bénéficiaires du RAMED se fait :

- A Uniquement dans les ESSB
- B Dans tous les services sanitaires relevant de l'Etat (ESSB et hôpitaux).
- C Dans les hôpitaux publics et privés
- D Toutes les réponses sont justes

! Only 4 options available in source.

45 La carte du RAMED permet l'accès :

- A A toutes les prestations médicales
- B a tous les actes de chirurgie
- C A toutes les prestations offertes par les services de l'état à l'exception des interventions de chirurgie plastique et esthétique
- D Toutes les prestations sans exception

! Only 4 options available in source.

46 Le SIDA est une maladie bactérienne transmise par voie sexuelle:

A Vrai

B Faux

C N/A

D N/A

! True/False question filled with dummy options.

47 La tuberculose est une maladie à déclaration obligatoire:

A Vrai

B Faux

C N/A

D N/A

! True/False question filled with dummy options.

48 L'incidence est le nombre de nouveaux cas de maladie:

A Vrai

B Faux

C N/A

D N/A

! True/False question filled with dummy options.

- 49 La régionalisation est un instrument politique pour mobiliser la participation des collectivités locales dans la planification et le financement des soins:

A Vrai

B Faux

C N/A

D N/A

! True/False question filled with dummy options.

- 50 La réforme hospitalière vise la préparation des hôpitaux à la transition sanitaire :

A Vrai

B Faux

C N/A

D N/A

! True/False question filled with dummy options.

- 51 La mortalité, ou taux de mortalité, est le nombre de décès annuels rapportés au nombre d'habitants d'un territoire donné:

A Vrai

B Faux

C N/A

D N/A

! True/False question filled with dummy options.

52 L'épidémiologie est l'étude des facteurs influant sur la santé et les maladies de population

A Vrai

B Faux

C N/A

D N/A

! True/False question filled with dummy options.

53 La prophylaxie désigne le processus passif ayant pour but d'éradiquer la maladie:

A Vrai

B Faux

C N/A

D N/A

! True/False question filled with dummy options.

54 La prévention secondaire vise à réduire la gravité d'un problème de santé :

A Vrai

B Faux

C N/A

D N/A

! True/False question filled with dummy options.